



Listas y tiempos de espera para atención en salud en Chile

Consultas nuevas de especialidad e intervenciones quirúrgicas, no GES,
en Red Pública de Salud: enero de 2022 a junio de 2024.

Autor: Eduardo Goldstein

egoldstein@bcn.cl

SUP N° 142609

I. Las listas de espera en Salud

La existencia de personas en espera de atención de consulta médica, ya sea de un procedimiento diagnóstico o de una intervención quirúrgica, son consustanciales a los sistemas de salud en la mayoría de los países (incluido países OCDE), de aquí que un aspecto fundamental en el desempeño del sistema son las capacidades que éste tiene para medirlas, monitorearlas y gestionarlas.

De modo general, el MINSAL concibe la lista de espera como “(...) aquella lista de enfermos a los que el médico u otro profesional habilitado ha indicado una intervención de cualquier tipo y que, por razones ajenas a la voluntad del enfermo, tienen que esperar para ser atendidos” (MINSAL, 2023).

A este respecto, en Chile es importante distinguir las listas de espera GES, a las cuales se le otorgan garantías exigibles y tiempos máximos de atención (actualmente corresponden a 87 problemas de salud vigentes)¹, de las listas de espera No GES, donde entran las patologías que no están priorizadas con el programa AUGE – GES². De aquí que las demoras en la resolución de problemas GES son tratados administrativamente como retrasos e incumplimientos de garantía legal y no como lista de espera, contando para ello con un sistema de registro separado (SIGGES³ en vez del SIGTE⁴ utilizado para la gestión de otros problemas de salud).

De acuerdo a declaraciones recientes de la Dra. Ximena Aguilera Sanhueza, Ministra de Salud, entre los ejes de trabajo en materia de listas de espera se encuentra el tema de

¹ Régimen de atención garantizado por ley que cubre 87 patologías y/o condiciones de salud en la actualidad. Los problemas de salud incluidos en este régimen se han venido incrementando en el tiempo desde que se publicó la Ley 19.996 en el año 2004 (estos se establecen por vía administrativa mediante Decreto firmado por Ministerios de Hacienda y Salud). Ver listado de problemas vigentes en: <https://www.superdesalud.gob.cl/difusion/665/w3-propertyvalue-1962.html#acordeonAuge>.

² Esta distinción entre patologías GES y no GES ha provocado asimetrías de acceso y oportunidad de atención en salud. Esto por los mayores esfuerzos que se destinan a resolver patologías que tienen un financiamiento especial, y están sujetas a una ley particular.

³ Sistema de Información para la Gestión de Garantías en Salud (SIGGES).

⁴ El Sistema de Información de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE). A este sistema migró en 2017 el antiguo Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE).

la transparencia y el fortalecimiento de los datos (MINSAL, 2024 a), de aquí que entre los portales del MINSAL se encuentra funcionando el **Visor Ciudadano de Tiempos de Espera**, que contiene estadísticas sobre la materia, las que se actualizan con periodicidad mensual ⁵.

Las listas No GES aquí consideradas son las que se generan desde los establecimientos de la red asistencial del sector público de salud, donde se incluyen los establecimientos de atención primaria, secundaria y terciaria, que generen derivaciones para consulta nueva de especialidad y establecimientos de nivel secundario-terciario que generen indicaciones de intervención quirúrgica (MINSAL, 2016). Se entiende que estas últimas corresponden a cirugías electivas⁶, por tanto, en estas cifras no se consideran las cirugías que ingresan y se resuelven de inmediato por atención de urgencia o emergencia médica.⁷

II. Número de casos en Lista de Espera No GES de atención en salud

De acuerdo a la plataforma del MINSAL, a junio de 2024, el número de casos de Lista de Espera No GES para **consultas nueva de especialidad médica y odontológica** alcanzaron los 2.555.918 registros⁸. De estos, existen 2.064.953 casos correspondientes a consultas médicas y 490.965 casos correspondientes a consulta de odontología. (Esto ubica a la especialidad de odontología entre las de mayor demanda insatisfecha, considerando que absorbe cerca de la quinta parte de la lista de espera total) Dentro de las consultas médicas no odontológicas, las especialidades de oftalmología y otorrinolaringología son las que presentan las listas más abultadas (368.360 y 260.757 casos, respectivamente), esto es, absorbiendo sólo estas dos especialidades, la cuarta parte del total la lista espera acumulada a mediados del presente año.

A la misma fecha (junio 2024), el número de casos de lista de espera para **Intervenciones Quirúrgicas** alcanzaba a 365.257 registros, donde los más frecuentes corresponden a Traumatología (82.141 casos), seguidos por Cirugía Digestiva (55.127) y Dermatología (49.215 casos). Las listas de espera de otros procedimientos son bastante menos abultadas (del orden de 27.000 casos o menos).

En cuanto a la **evolución del número de casos** en espera, mientras que las consultas de especialidad muestran un crecimiento sostenido desde enero de 2022 a la fecha, el número de casos en espera de una cirugía muestra que, luego de un descenso progresivo entre agosto a 2022 y mayo 2023, el número de casos en espera se vuelve a incrementar de forma sostenida en los últimos 12 meses (junio 2023 a junio 2024).

⁵ Disponible en <https://public.tableau.com/app/profile/tableau.minsal/viz/PortadaLE/PortadaLE>.

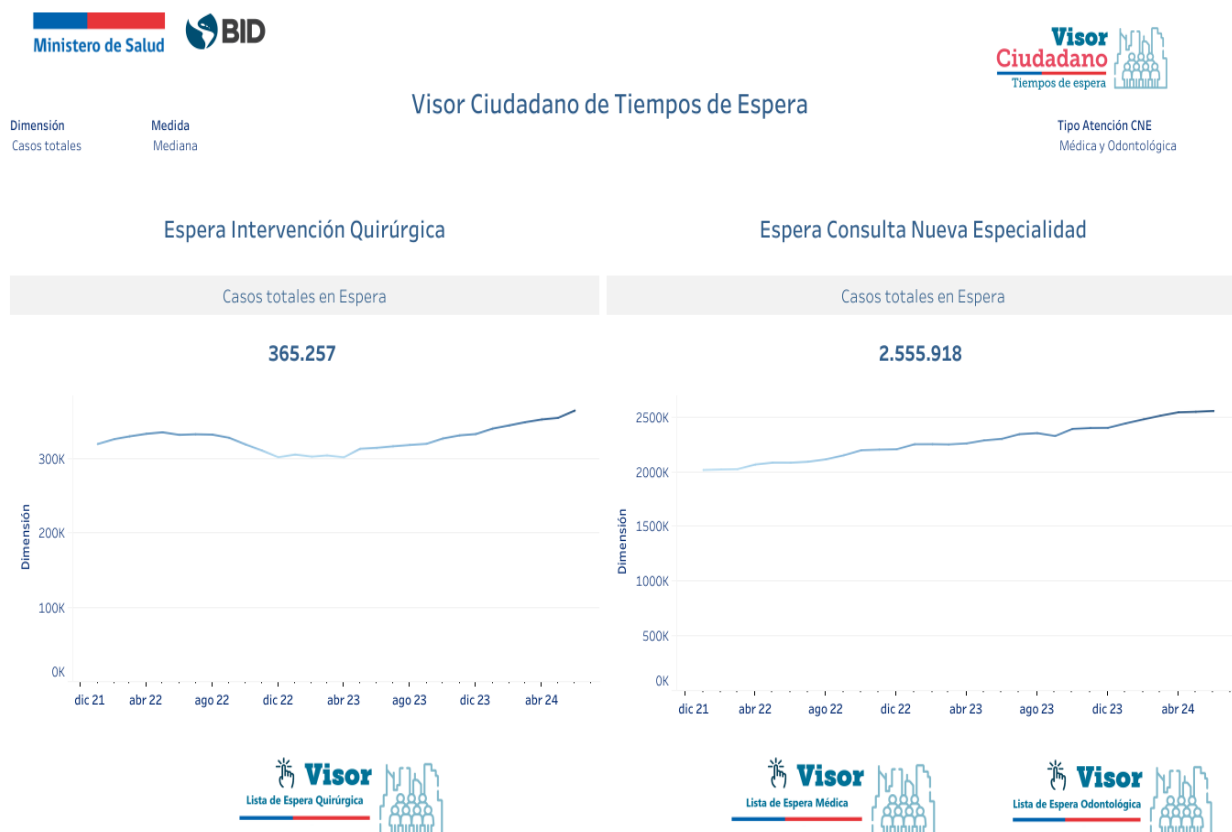
⁶ Una cirugía electiva acontece cuando el paciente tiene el tiempo necesario para evaluar cuidadosamente los riesgos y beneficios del procedimiento e identificar qué es lo más adecuado para su tratamiento.

⁷ En general de las listas de espera No GES se egresa de tres maneras principales: 1) cuando se obtiene una atención (se denomina resuelta); 2) cuando la persona fallece (se denomina egreso administrativo) y 3) cuando la persona es inubicable, ya ha solucionado su derivación por otros medios

Dado que el sistema puede considerar más de un registro para una misma persona (por derivación a distintas especialidades), en esta contabilidad se estima un promedio de 1,2 casos por persona.

La evolución, entre 2022 y 2024, de los registros en listas de espera para intervención quirúrgica y consulta de nueva especialidad se puede ver en la Figura N°1 a continuación.

Figura N°1. Número de Casos de Espera en Consulta nueva de Especialidad e Intervención Quirúrgica, período enero 2022 a junio 2024



Fuente: MINSAL (2024) – Visor Ciudadano de Tiempos de Espera. Disponible en <http://bcn.cl/3sk4a>

III. Tiempos de Espera de atención en salud por Problemas No GES

Siguiendo recomendaciones de OCDE, en los últimos años, el MINSAL ha puesto el foco en los tiempos de espera para el monitoreo y gestión de las listas de espera de atención en las diferentes especialidades médicas⁹. Esto es, considerando más recientemente la ‘mediana’ (el valor que se ubica en el punto medio de la serie de casos ordenados según la cantidad de días de espera) como la principal métrica de evaluación de la tendencia y avances en estas materias¹⁰.

A junio de 2024, la **mediana de espera para consulta nueva de especialidad** es de 255 días, lo que significa que la mitad de los casos que están en la lista de espera por una atención médica de especialidad llevan 255 días o más esperando desde su derivación¹¹. Cabe notar que, a estos

⁹ MINSAL (2017). Plan Nacional de Tiempos de Espera No GES en Chile en Modelo de Atención en RISS (Redes Integradas de Servicios de Salud) 2014-2018. Subsecretaría de Redes Asistenciales. Disponible en <http://bcn.cl/3sk96>

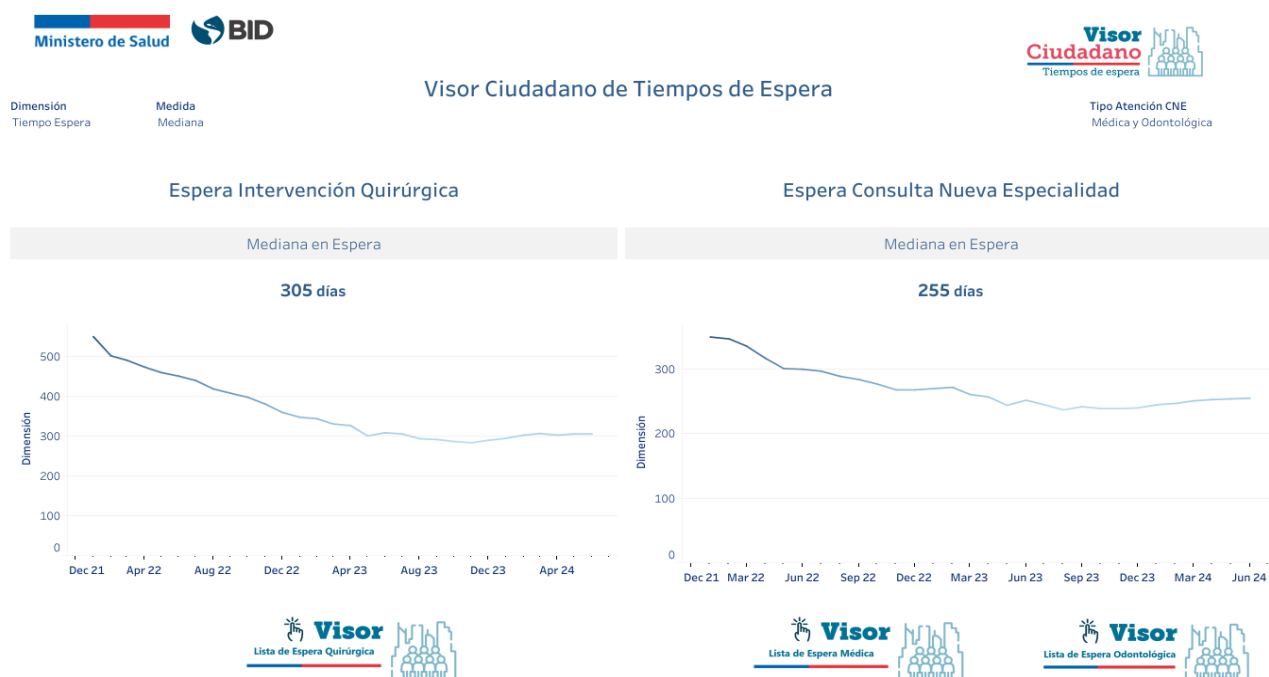
¹⁰ Este estadígrafo es una medida de tendencia central que, a diferencia del valor promedio utilizado con anterioridad, se caracteriza por proporcionar un valor que no está afectado por casos extremos (casos con demoras inusualmente más extensas). De aquí que la mediana tiende a adquirir valores inferiores al promedio.

¹¹ Si bien a la fecha de esta consulta no se encontraron definiciones metodológicas en la plataforma del Visor Ciudadano publicado por MINSAL para transparentar los tiempos de espera, damos por entendido que la “mediana

plazos, se llega luego que se ha producido un brusco descenso en los tiempos de espera, como muestran la evolución de las cifras observadas con posterioridad al fin de la pandemia de covid-19, tendencia que se mantiene hasta finales del año 2023¹² (véase Figura N°2, a continuación). A contrario sensu, durante el transcurso del presente año, se observa un incremento progresivo de los tiempos de espera, llegando así a una mediana de 255 días en junio 2024 (lo que contrasta con los 240 días observados en diciembre de 2023). A este respecto, cabe mencionar que la autoridad sanitaria ha hecho notar que la tendencia más general de reducción de tiempos de espera en el largo plazo se produce en concomitancia con el aumento sostenido de la demanda de atención (número de casos ingresados en la lista de espera por atención de especialidad) (MINSAL, 2024 b).

Cabe considerar que, luego de finalizado el periodo de pandemia covid-19, se produjo un rápido descenso en los **tiempos de espera para cirugía**, donde la mediana de espera se reduce de 549 días (más de un año y medio), en enero 2022, a una mediana de 300 días en mayo 2023. Los tiempos de espera se estabilizan posteriormente, observándose que en junio de 2024 la mitad de los casos que conforman la lista de cirugía han tenido una espera de 305 días o menos desde que fueran indicadas. Véase Figura N°2, a continuación.

Figura N°2: Tiempos de espera (número de días) en ‘Consulta nueva de especialidad’ e ‘Intervención Quirúrgica’, periodo enero 2022 a junio 2024.



Fuente: MINSAL (2024) – Visor Ciudadano de Tiempos de Espera. Disponible en <http://bcn.cl/3sk3k>

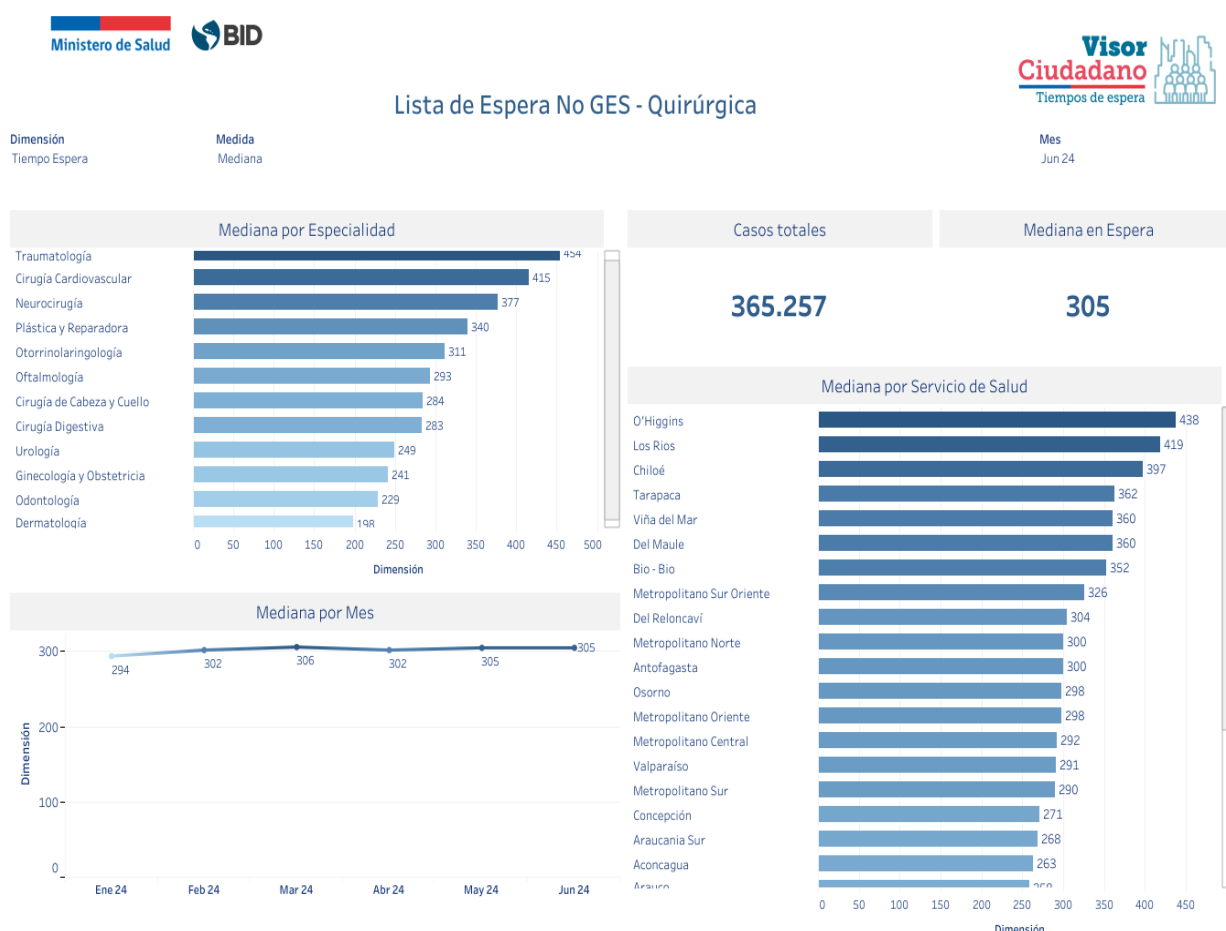
de los tiempos de espera” aquí publicada difiere de la métrica que se podría construir en base a los tiempos de resolución, esto es, sobre la base del universo de casos que accedieron a la atención para la cual fueron derivados. (En este caso cabe igualmente distinguir la resolución por acceder a la consulta de especialidad y la resolución completa del problema de salud cuando este requiere procedimientos adicionales)

¹² Así, a pesar del aumento en el número de casos, los tiempos de espera entre junio 2021 y junio 2024, se reducen a menos de la mitad. Esto es, pasando de una mediana de 520 días a 255 días en el transcurso de los 3 años consecutivos al pick del tiempo de espera post pandemia.

Cabe advertir que, entre las intervenciones quirúrgicas más demorosas de resolver, se encuentran las de Traumatología (mediana de 454 días), Cirugía Cardiovascular (mediana de 415 días) y Neurocirugía (mediana de 377 días). Para los otros tipos de cirugías, se estima que la mediana de espera actualmente es menor de un año; en otras palabras, al menos la mitad de los casos de la lista tienen menos de 365 días de espera desde su derivación. Al respecto, véase Figura N°3.

Luego al ordenar los diferentes Servicios de Salud según la mediana de tiempos de espera de las cirugías sin resolver, se advierte que: el S.S. O'Higgins (438 días), S.S. de Los Ríos (419 días) y el S.S. de Chiloé (397 días) son los que actualmente presentan más demora para acceder al conjunto de intervenciones quirúrgicas a ellos derivada. En cambio, en los demás Servicios de Salud, los tiempos medianos de espera se estiman en menos de un año. Al respecto, véase Figura N°3, a continuación.

Figura 3: Mediana de tiempos de espera por cirugía, en orden descendente de especialidad y Servicio de Salud



Fuente: MINSAL (2024) – Visor Ciudadano de Tiempos de Espera. Disponible en <http://bcn.cl/3skyb>

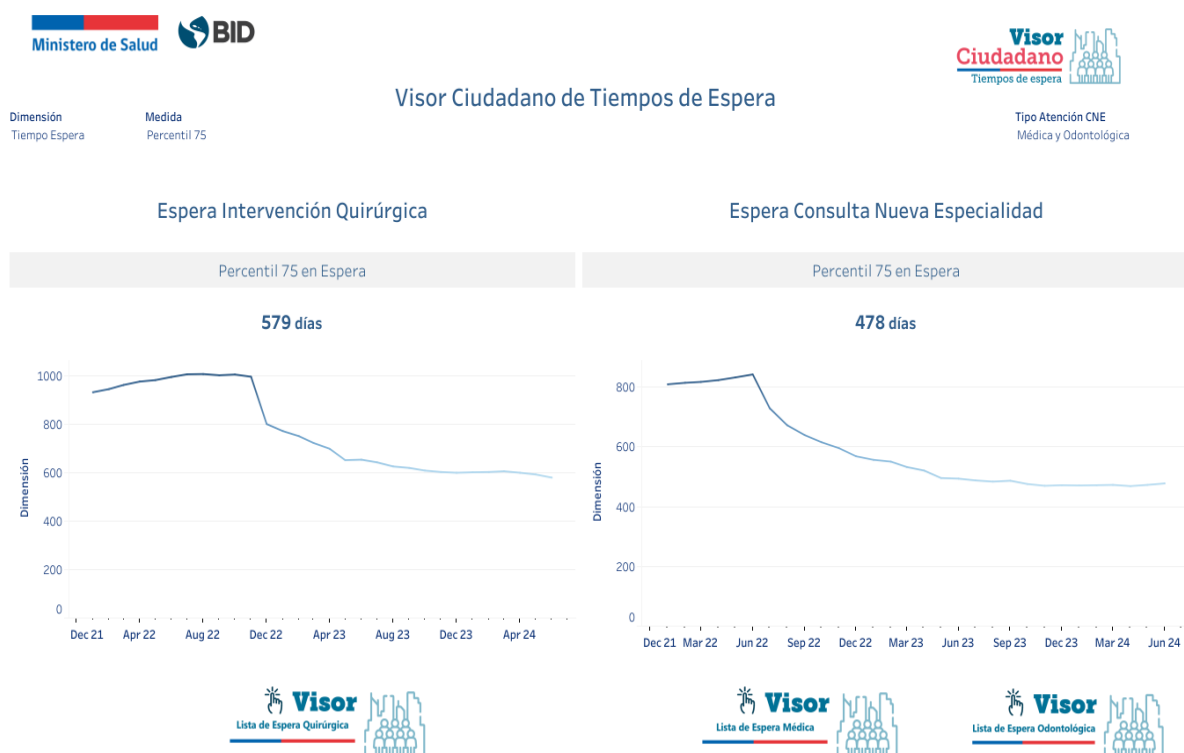
IV. Variación de los registros con mayor antigüedad en la lista de espera por atención

Si atendemos a los casos con mayor tiempo de espera por una cirugía, como lo indica el percentil 75 de la distribución, se observa que, a junio 2024, una cuarta parte de la lista lleva esperando más de 579 días por una cirugía. Esto significa, que cuando consideramos la lista de espera más antigua (casos con más demora), actualmente se encuentra un contingente de cerca de 91.314 pacientes que han estado esperando más de año medio desde que les fuera indicada la intervención, sin que ésta se haya resuelto según los registros de junio 2024.

En cuanto a la evolución de las listas de espera más antiguas para cirugía, la Figura N°4 muestra que los casos con más demora tuvieron una fuerte disminución a fines del año 2022 (sólo en mes de diciembre el percentil 75 se reduce en un 20% aprox.). Esto es, luego que el percentil 75 se mantuvo en valores próximos a los 1.000 días de espera durante el segundo semestre 2022. Luego de la caída señalada,¹³ este estimador mantiene una tendencia al decrecimiento gradual los últimos 2 años, pasando así de 800 días en diciembre 2022 a 579 días en junio 2024.

En el caso de las Consultas de nueva especialidad, la reducción de los casos con más tiempo de espera se inicia en junio del año 2022, con una tendencia al descenso que disminuye de forma gradual (véase Figura N°4, a continuación).

Figura 4: Percentil 75 de tiempos de espera por Consulta Nueva Especialidad y Cirugía

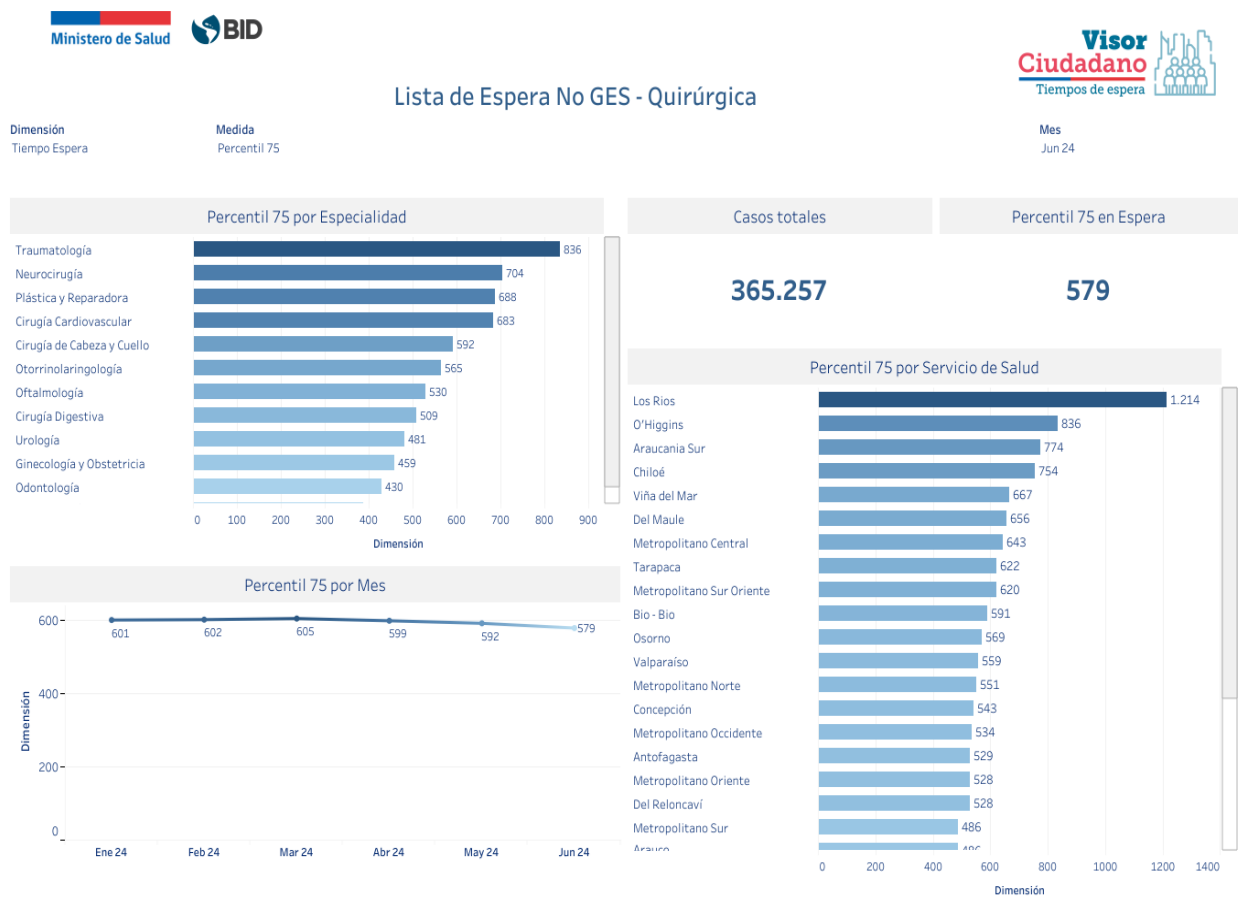


Fuente: MINSAL (2024) – Visor Ciudadano de Tiempos de Espera. Disponible en <http://bcn.cl/3sn34>

¹³ Las reducciones aceleradas de los casos con más tiempo de espera, pueden ser efecto de una priorización para resolver los casos más antiguos, y/o efecto de una validación y limpieza de listas de espera (egresos administrativos por fallecimientos o problemas que el paciente resolvió fuera de la red)

Al comparar el percentil 75 de la lista de espera de los distintos Servicios de Salud, las cirugías pendientes del Servicio de Salud de los Ríos es el que, actualmente, concentra los casos extremos con más demora, es decir, donde la lista de junio de 2024 registra 1.872 pacientes con más de 3 años de espera (percentil 75 de tiempo de espera de 1.214 días). Ver Servicios de Salud en orden descendente según este indicador en la Figura N°5, a continuación.

Figura 5: Percentil 75 de tiempos de espera por Intervención Quirúrgica según especialidad y Servicio de Salud (en orden descendente)



Fuente: MINSAL (2024) – Visor Ciudadano de Tiempos de Espera. Disponible <http://bcn.cl/3snfr>

Referencias

- MINSAL (2024 a). Ministra de Salud: “Es muy importante que se entienda que es una prioridad tener tiempos oportunos de espera” publicado sitio web oficial el 14 de agosto de 2024. Disponible en <https://www.minsal.cl/ministra-de-salud-es-muy-importante-que-se-entienda-que-es-una-prioridad-tener-tiempos-oportunos-de-espera/> (agosto, 2023).
- MINSAL (2024 b) “Tiempos de espera no GES y garantías de oportunidad GES retrasadas”. Exposición de la Ministra de Salud, Dra. X. Aguilera y del Subsecretario de redes Asistenciales, Dr. O. Salgado, ante Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y Diputadas el 12 de agosto 2024 (sesión 120). Disponible en <https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/documentos.aspx?prmID=3311> (agosto, 2023).
- MINSAL (2023) Tiempos de Espera en la Red Asistencial, junio 2023. Exposición del Subsecretario de Redes Asistenciales, Dr. Osvaldo Salgado, ante Comisión de Salud del Senado en sesión del lunes 7 de agosto 2023. https://www.senado.cl/appsenado/index.php?mo=comisiones&ac=sesiones_celebradas&idcomision=195&tipo=3&ano=2023&idsesion=19220&listado=2&idsesion=19220 (agosto, 2023).
- MINSAL (2016). Manual Procesos de Registro de Lista de Espera no GES. Disponible en <http://www.repositoriodigital.minsal.cl/handle/2015/578> (agosto, 2023).

Nota Aclaratoria

Asesoría Técnica Parlamentaria está enfocada en apoyar preferentemente el trabajo de las Comisiones Legislativas de ambas Cámaras, con especial atención al seguimiento de los proyectos de ley. Con lo cual se pretende contribuir a la certeza legislativa y a disminuir la brecha de disponibilidad de información y análisis entre Legislativo y Ejecutivo.



Creative Commons Attribution 3.0
(CC BY 3.0 CL)